

ANAMNESA DAN TEKNIK PEMERIKSAAN TELINGA, HIDUNG, DAN TENGGOROK

Dr. Faridatul Jannah Sp THT KL

Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang 2021

I. Pemeriksaan Telinga

Pemeriksaan Telinga meliputi

- Aurikulum
- Meatus Akustikus Eksternus (MAE)
- Membrana Timpani (MT)

TELINGA

Riwayat Penyakit Sekarang

- Nyeri telinga?
- Keluar cairan?
- Gatal?
- Penurunan pendengaran?
- Telinga rasa penuh? Buntu?
- Berdenging? Berdengung?
- Pusing berputar? Mual? Muntah?
- Gangguan keseimbangan

Riwayat Penyakit Dahulu

- Riwayat keluar cairan sebelumnya
- Riwayat trauma
- Riwayat korek telinga

Pemeriksaan Telinga

ALAT

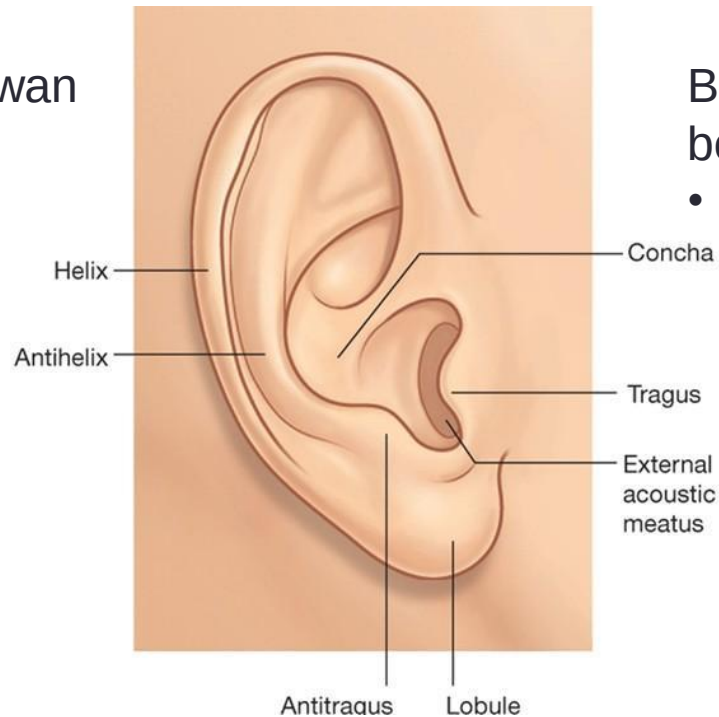
- Lampu kepala
- Corong telinga
- Otoskop
- Pelilit kapas
- Pengait serumen
- Pinset telinga
- Garputala

Aurikulum

Aurikulum terdiri dari

Bagian yang bertulang rawan

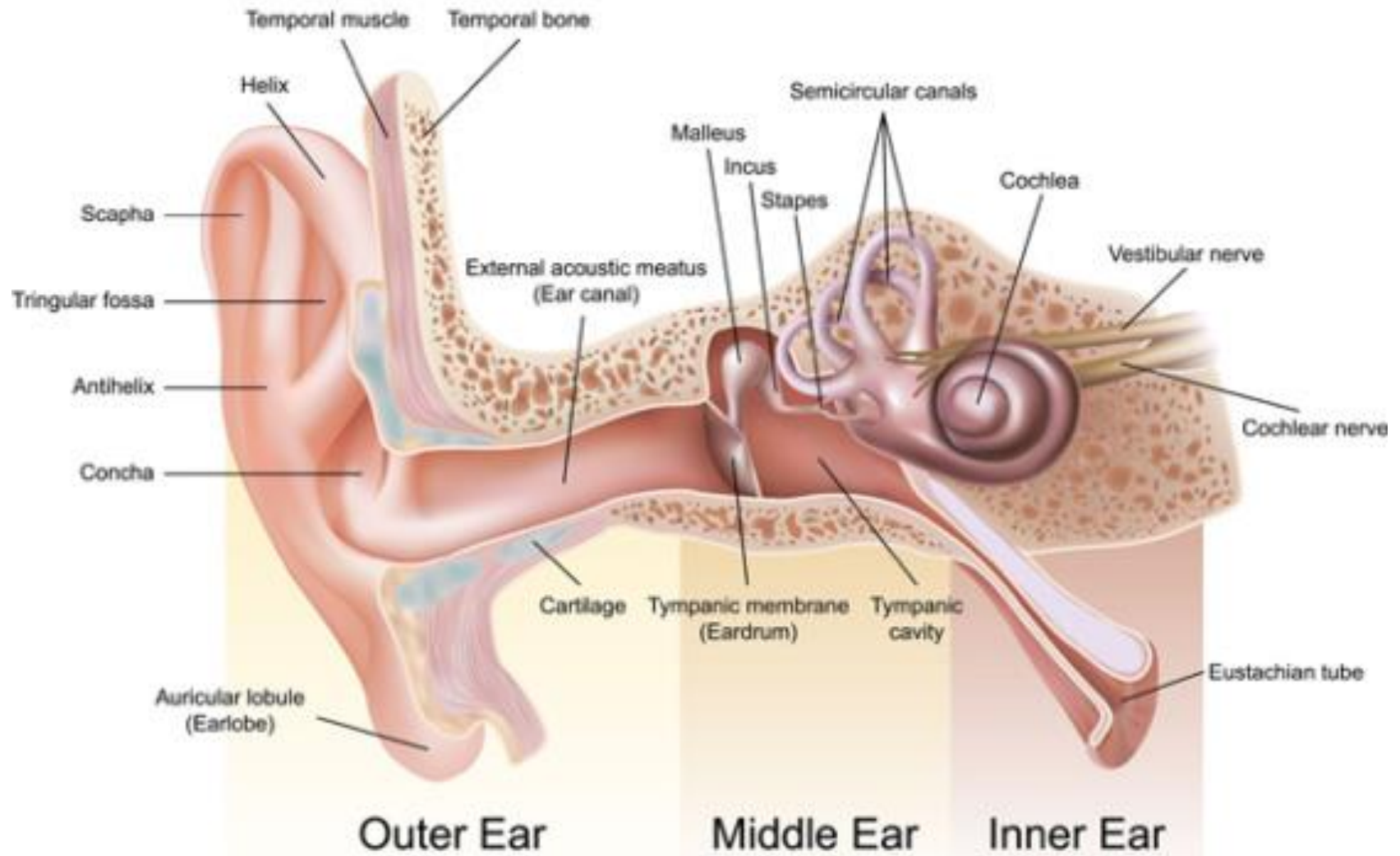
- Heliks dan Antiheliks
- Tragus dan Antitragus
- Konka
- Sulkus Retroaurikular



Bagian yang tidak bertulang belakang

- Lobulus

MAE



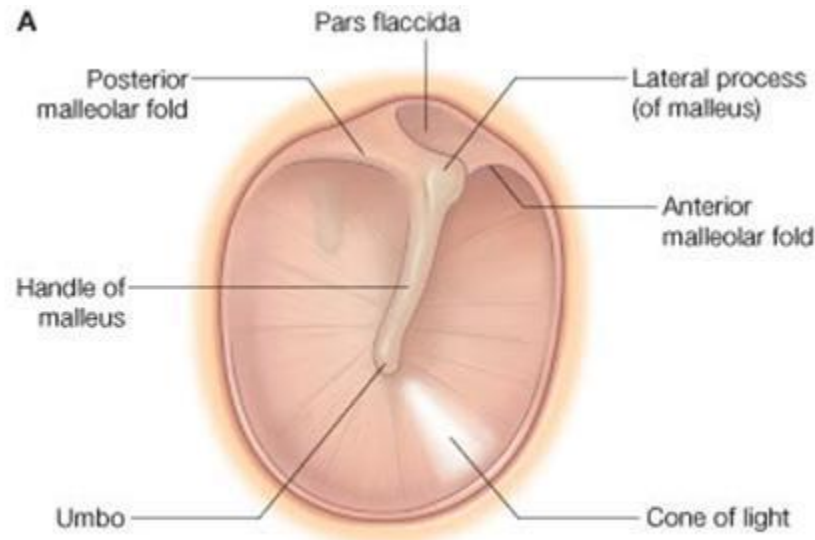
Bagian lateral adalah pars kartilagenus

- Merupakan lanjutan dari aurikulum
- Punya rambut, kelenjar sebacea, kelenjar serumenalis
- Kulit melekat erat dengan perikondrium

Bagian Medial adalah pars asseus

- Bagian dari os temporale
- Tidak berambut
- Ada penyempitan yaitu isthmus MAE
- Tidak mobile terhadap sekitar

Membran Timpani



© Elsevier. Drake et al: Gray's Anatomy for Students - www.studentconsult.com

- Posisi Membentuk sudut 45° dengan bidang horizontal dan sagital
- Tepi bawah 6 mm lebih medial dari tepi atas
- Warna putih mengkilat seperti mutiara
- Ukuran tinggi 9-10 mm, lebar 8-9 mm
- Bentuk oval condong ke anterior

Bagian MT

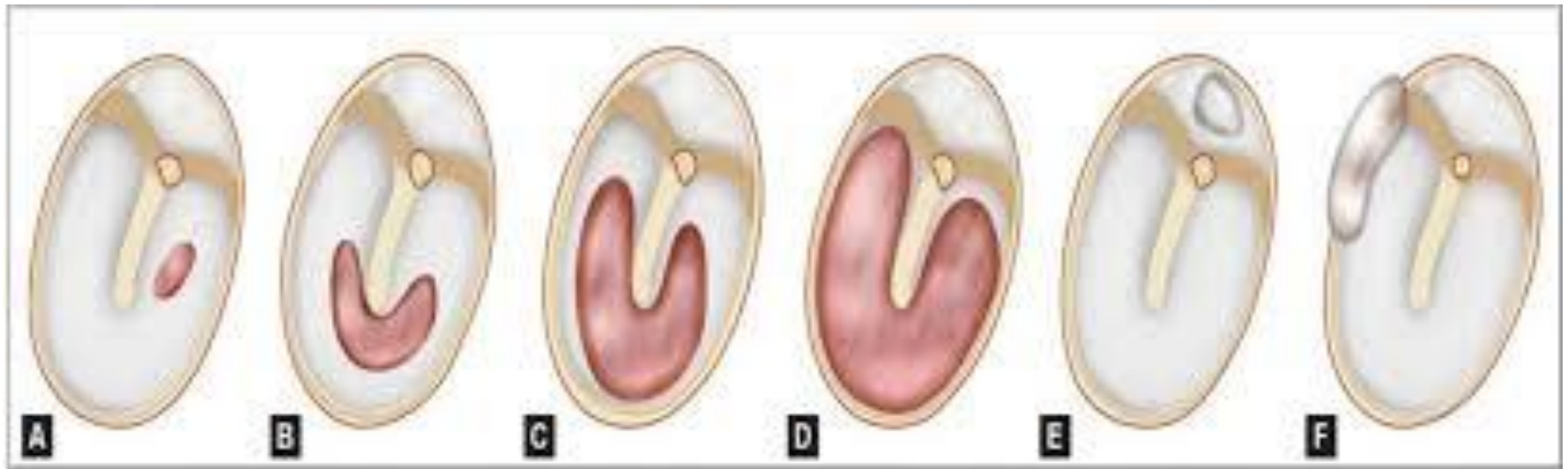
Pas tensa

- Manubrium mallei
- Umbo
- Prosesus bervis
- Reflek cahaya
- Plika anterior dan posterior

Pas Flaksida

- Membrana Schrapnelli

Patologi



Cara Pemeriksaan Telinga

alat



Otoscope



Ear Speculum



Garpu tala 512 Hz



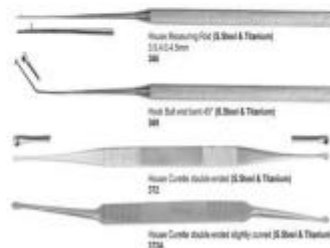
Lampu spiritus



Magill Forcep



Ear & Nasal foreign body remover



Hook & cures



Head lamp



Pinset Bayonet



Alligator forceps



Aplikator



Pinset telinga



Mangkuk bengkok (nearbeken)



Lidi kapas steril



Tongue depressor



Pneumatic Otoscope Siegel



Nasal speculum (kecil, sedang, besar)



Cermin laring

Posisi duduk



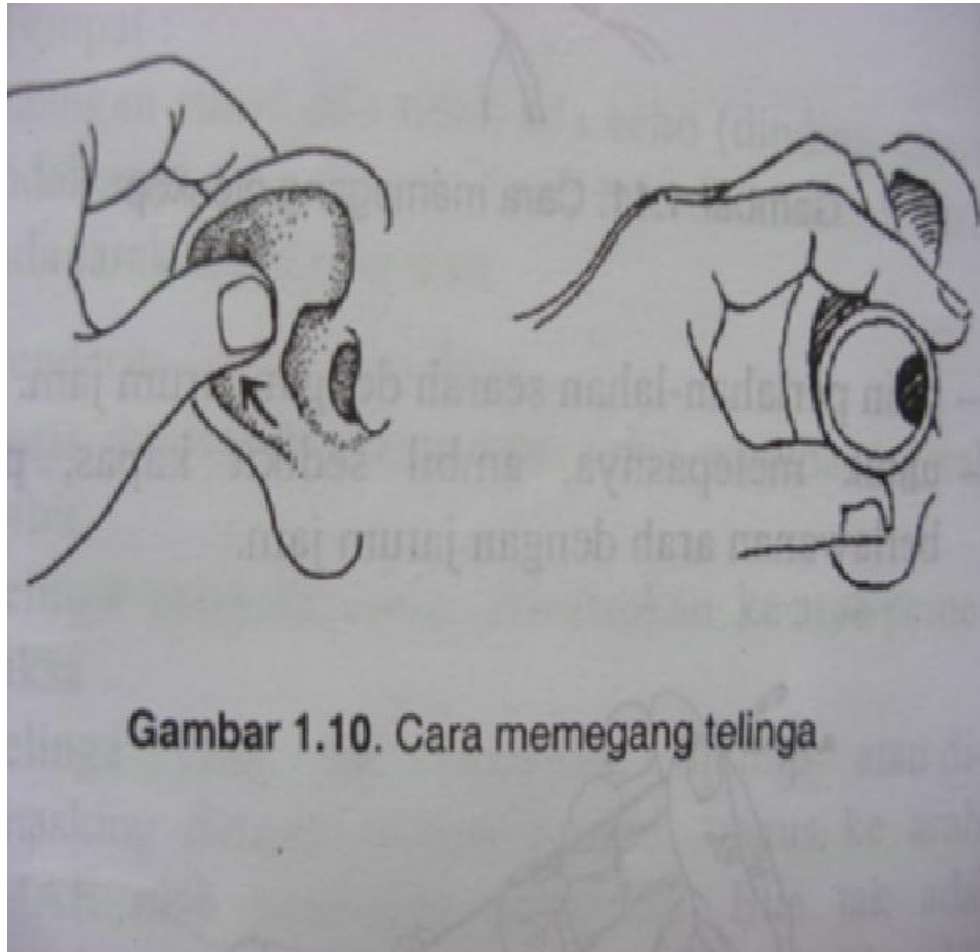


PHOTO COURTESY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA



Cara memakai lampu kepala

Cara memegang telinga



Cara memegang otoskop



Cara memilin kapas



Tes Pendengaran

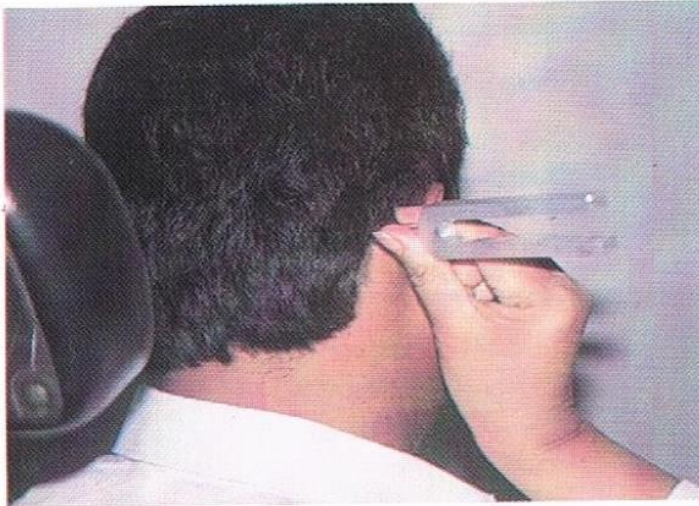
- I. Tes Bisik
- II. Tes garpu tala

PEMERIKSAAN PENALA



Menggetarkan penala

Tes Rinne



Uji Rinne : hantaran tulang



Uji Rinne : hantaran udara

Tes Webber



Uji Weber

II. Pemeriksaan Hidung

Anatomi

- Dorsum nasi
- Septum nasi
- Kavum nasi
- Sinus Paranasalis

HIDUNG

- ▶ Sumbatan hidung
- ▶ Sekret hidung dan tenggorok
- ▶ Bersin
- ▶ Rasa nyeri daerah wajah dan kepala
- ▶ Perdarahan dari hidung
- ▶ Gangguan penghidu



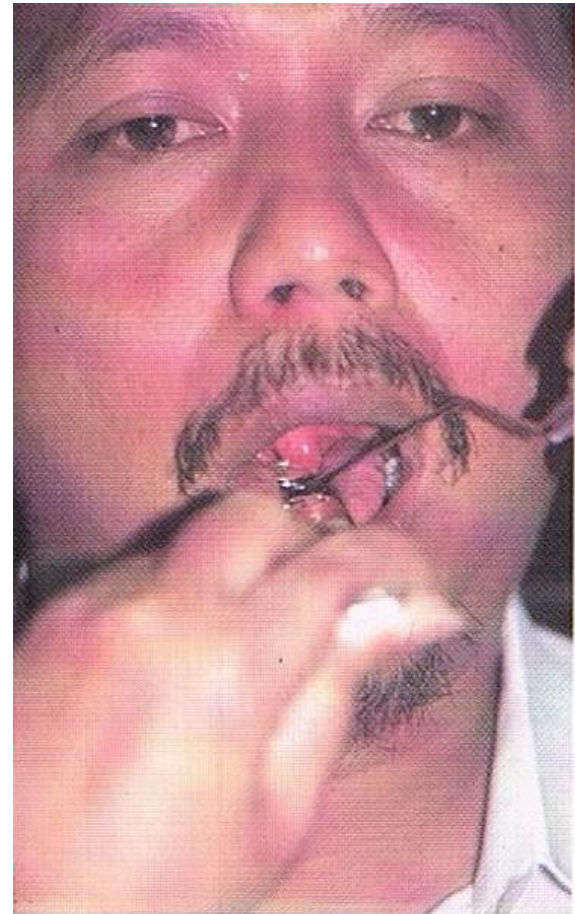
Pemeriksaan Hidung

ALAT

Lampu kepala

Spekulum hidung





Rinoskopi posterior

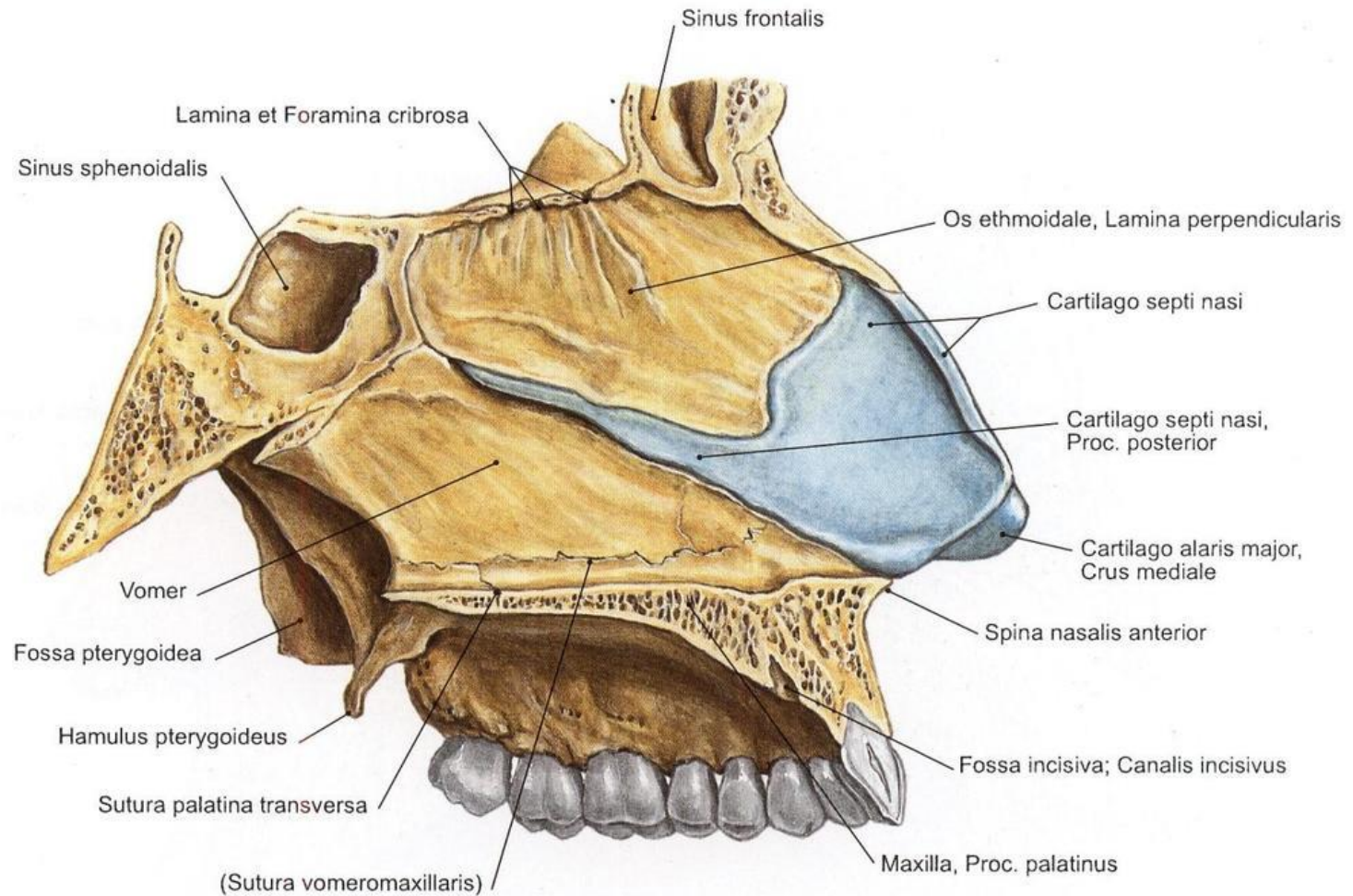
Dorsum Nasi

Batang Hidung (Dorsum nasi) terdiri dari

- Bagian yang keras (kranial):
 - os nasalis kanan/kiri, pros. Frontalis osis maksila
- Bagian yang lunak (kaudal) :
 - Kartilago lateralis dan kartilago alaris



Septum nasi

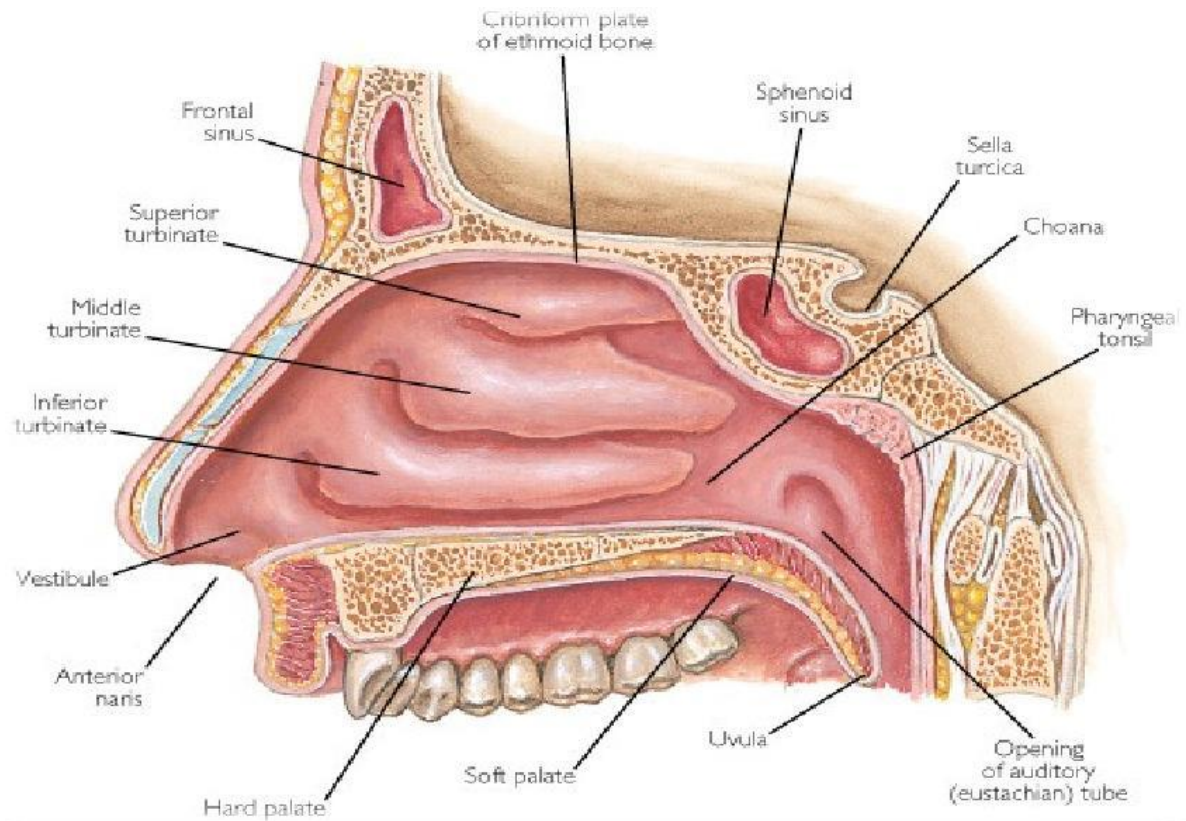


- Bagian posterior
 - Lamina perpendikularis os ethmoidalis, vomer
- Bagian anterior
 - Tulang rawan kartilago quadraangularis

Kavum nasi

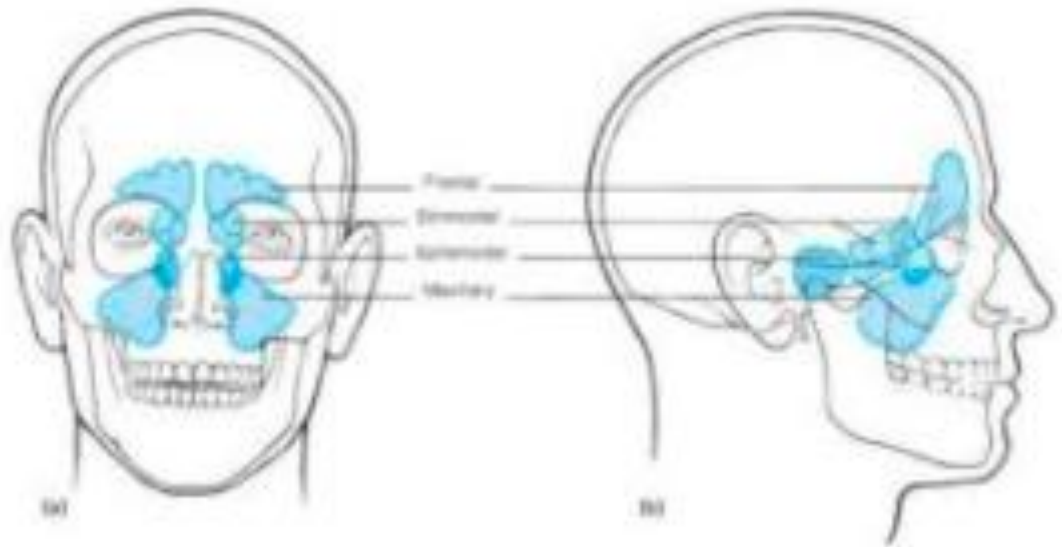
Batas Batas

- Medial : septum nasi
- Lateral :
 - Konka superior, medius, inferior,
 - meatus superior, medius, inferior
- Anterior : nares
- Posterior : Koane
- Superior : lamina kribrosa
- Inferior : palatum durum



Sinus paranasalis

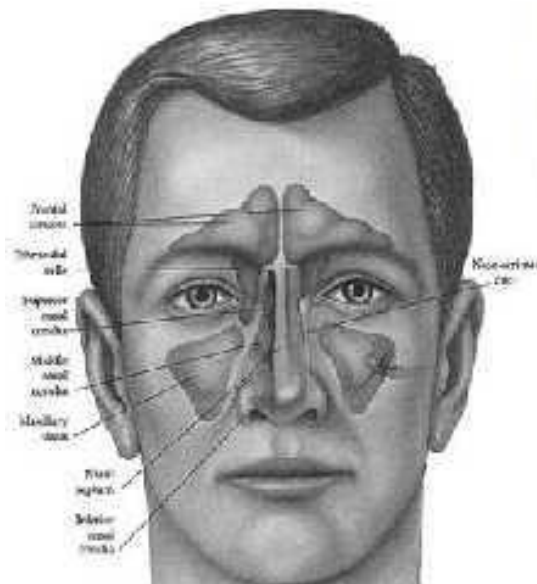
- Golongan anterior
 - Sinus maksilaris, sinus etmoidalis anterior, sinus frontalis
- Golongan posterior
 - Etmoidalis posterior, sinus sfenoidalis



Pemeriksaan hidung dan paranasalis

- Pemeriksaan hidung dari luar
- Rinuskopia anterior
- Rinuskopia posterior
- X-foto : waters
- Biopsi
- Naso Endoskopi

Palpasi sinus maksilaris dan frontalis



(a)



(b)



(c)

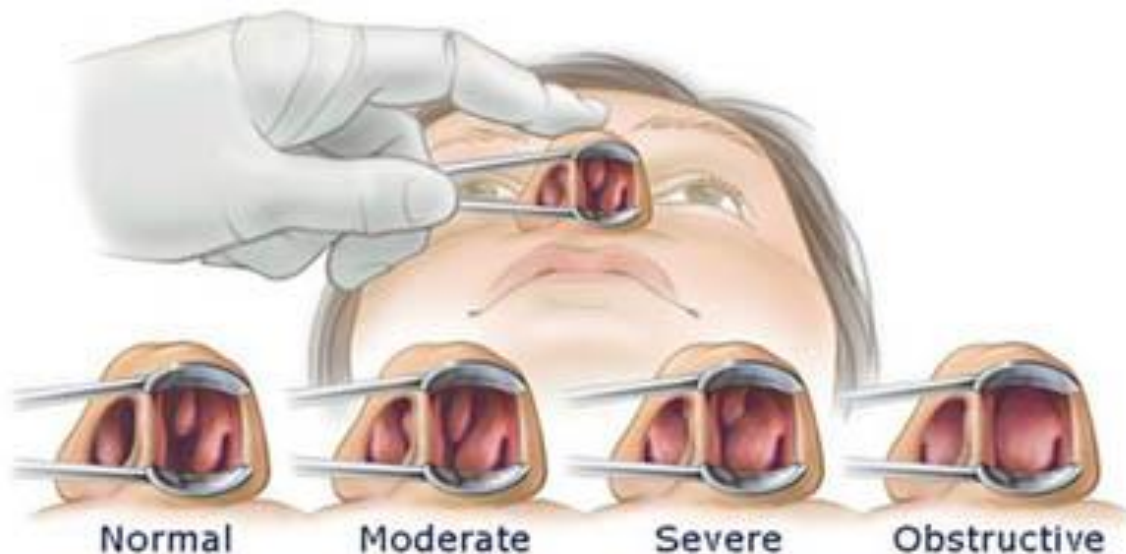
Rinoskopi anterior

- Alat
- Spikulum hidung
- Pinset bayonet
- Aplikator
- Kaca rinoskopi posterior
- Pipa penghisap
- Suction



Memeriksa kavum nasi bagian bawah

- Arahkan lampu ke arah kavum nasi sehingga sejajar dengan konka inferior, perhatikan
 - warna mukosa dan konka inferior hiperemi, pucat, biru/lifid
 - Besarnya lumen kavum nasi
 - Lantai kavum nasi
 - Septum deviasi, krista atau spina



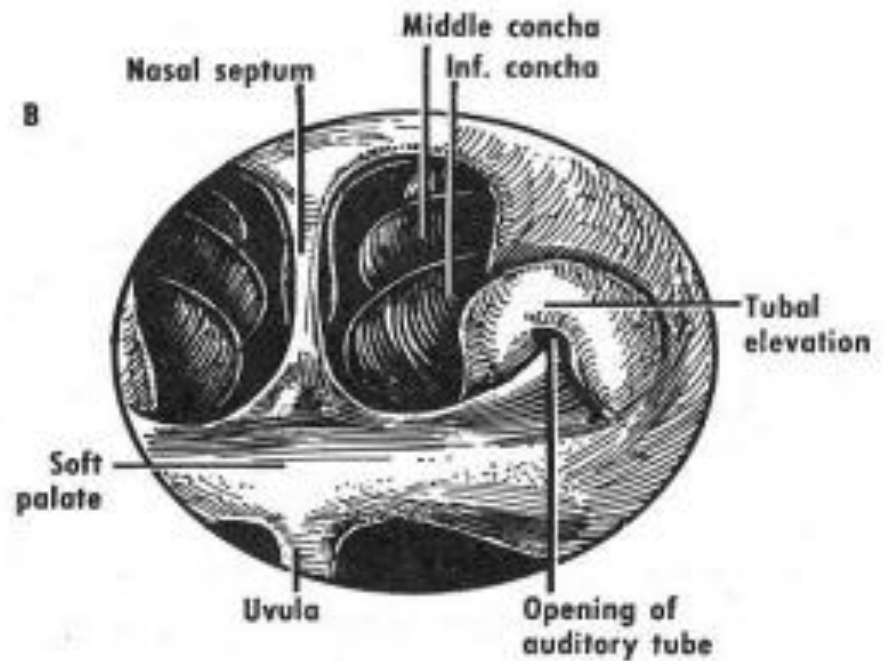
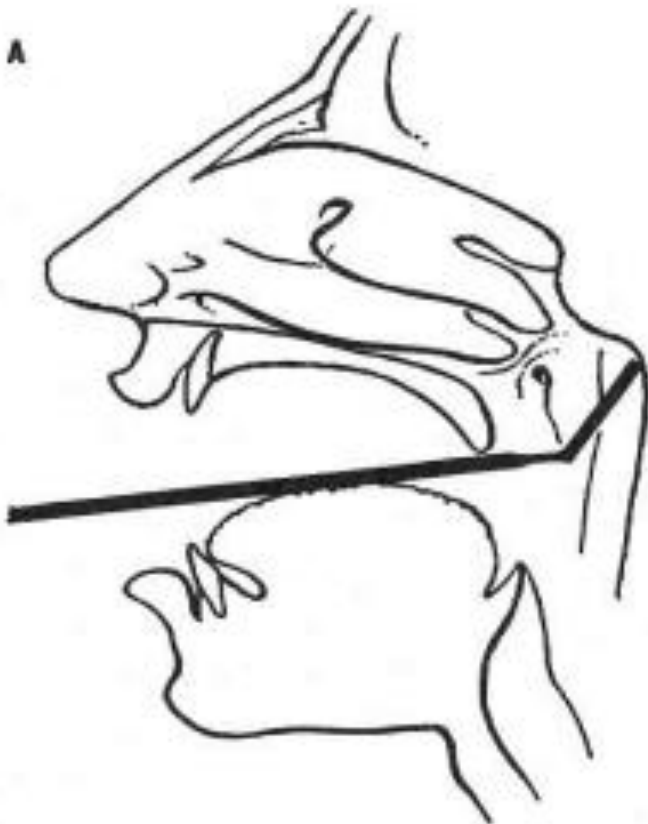
Rinoskopi posterior

Urutan pemeriksaan :

- 1) Lakukan penyemprotan pada rongga mulut dengan lidokain *spray* 2%.
- 2) Tunggu beberapa menit.
- 3) Ambil kaca laring ukuran kecil.
- 4) Masukkan/ pasang kaca laring pada daerah isthmus faucium arah kaca ke kranial.
- 5) Evaluasi bayangan-bayangan di rongga hidung posterior (nasofaring).
- 6) Lihat bayangan di nasofaring :
 - Fossa Rosenmüller
 - Torus tubarius
 - Muara tuba auditiva Eustachii
 - Adenoid
 - Konka superior
 - Septum nasi posterior
 - Choana

Alat

- Kaca rinoskopi posterior



III. Tenggorok

Cavum Oris

- Palatum molle
- Uvula
- Arkus Anterior
- Arkus Posterior
- Tonsil



FARING dan RONGGA MULUT

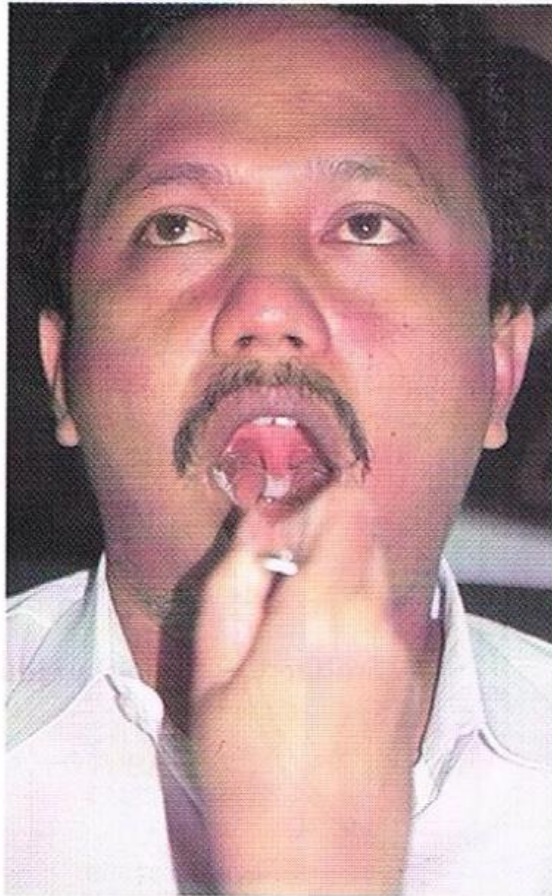
- ▶ Nyeri tenggorok
- ▶ Nyeri menelan
- ▶ Rasa banyak dahak di tenggorok
- ▶ Sulit menelan
- ▶ Rasa ganjal atau menyumbat



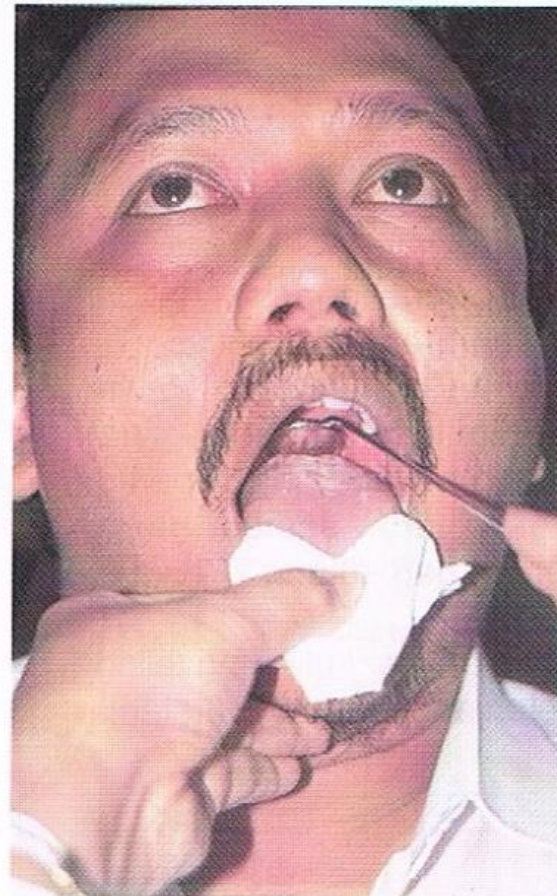
HIPOFARING dan LARING

- ▶ Suara serak
- ▶ Batuk
- ▶ Disfagia
- ▶ Rasa ada sesuatu di leher





**Pemeriksaan rongga mulut,
faring dan tonsil**



Pemeriksaan laring

Pembesaran tonsil



0

Surgically removed tonsils



1

Tonsils hidden within tonsil pillars



2

Tonsils extending to the pillars



3

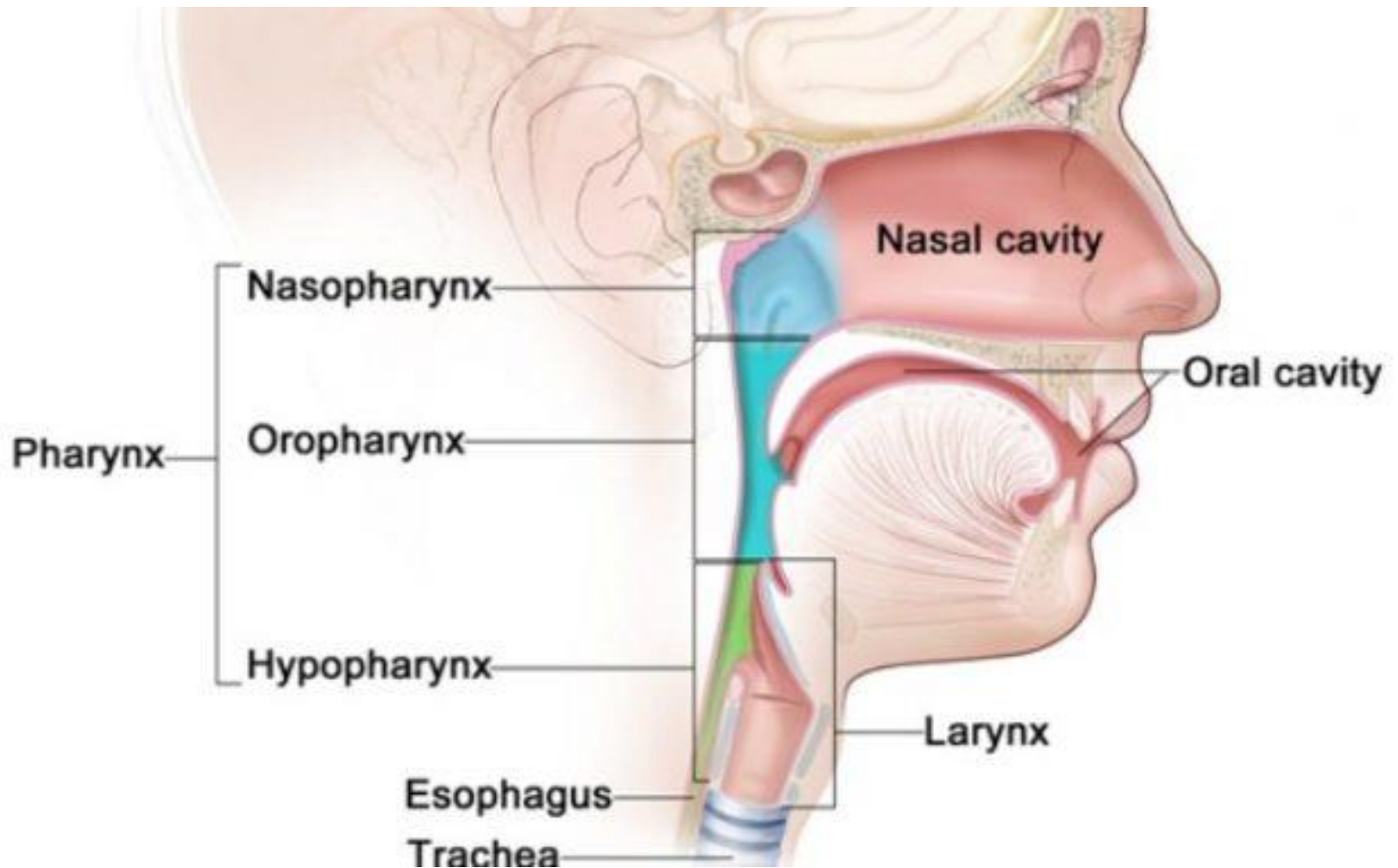
Tonsils are beyond the pillars



4

Tonsils extend to midline

Faring



Pemeriksaan Mulut

Perhatikan

- Ptialismus, trismus
- Gerakan bibir dan mulut
- Mukosa dan ginggiva
- Gigi yang rusak
- Lidah : parese N.XII, atrofi, aftae, tumor, ulkus/malignan
- Palatum durum (torus platinus)

Tonsil

- Mulut dibuka lebar, lidah ditekan kebawah dibagian medial
- Pasien disuruh bernafas
- Pasien mengucapkan “A”
- Diperhatikan besarnya tonsil (T0-T4)
- Memeriksa mobilitas tonsil
- Memeriksa patologi dan palato molle dari tonsil

Memeriksa Patologi Faring

- Faringitis akut (semua merah)
- Faringitis kronis (hanya granulae merah, Aftae, difteri, korpus alienum)

Laringoskopia indirektal

Alat :

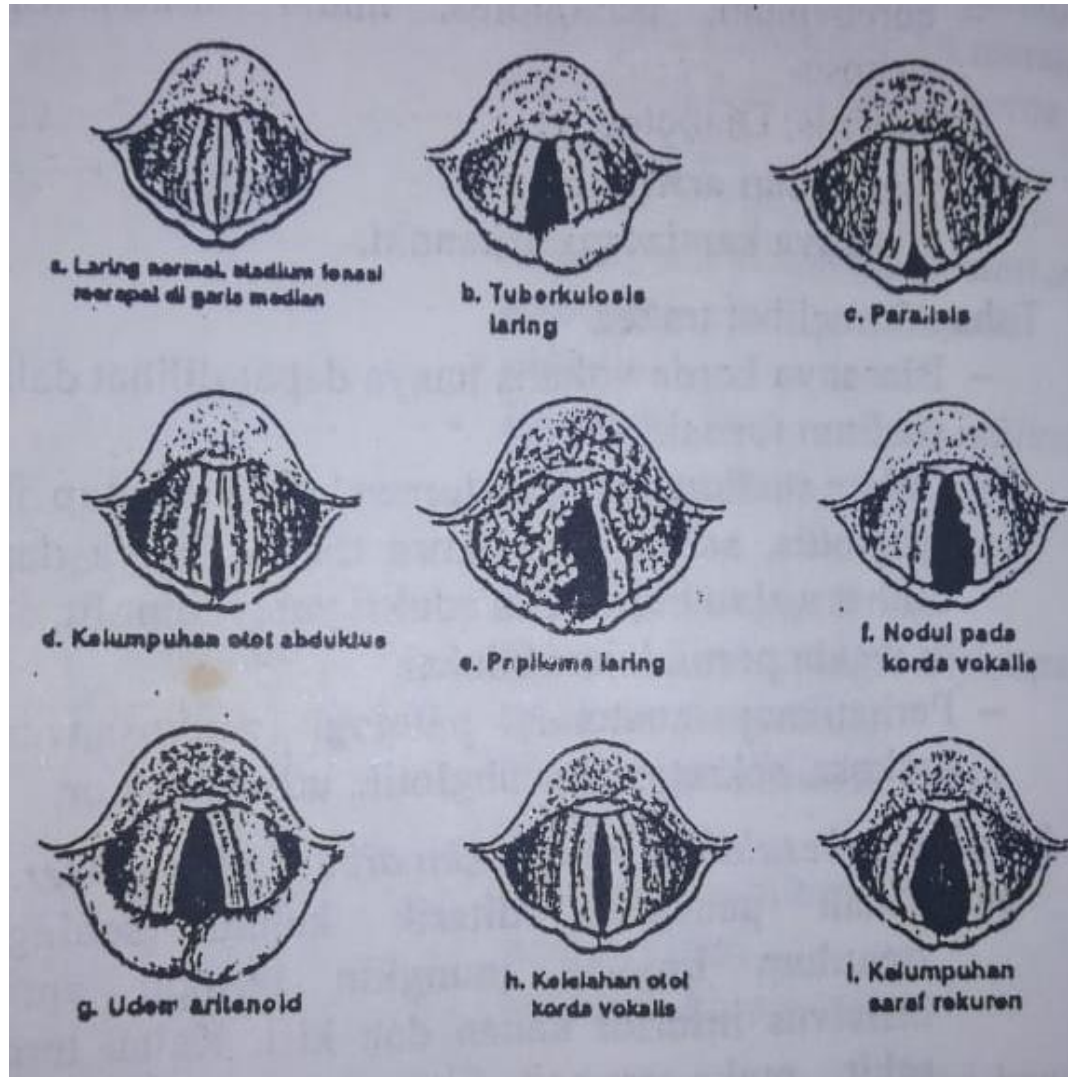
- Kaca laring

Yang perlu diperhatikan

1. Epiglotis
2. Korda vokalis
3. Komisura anterior
4. Komisura posterior
5. Aritenoid
6. Plika ari epiglotika



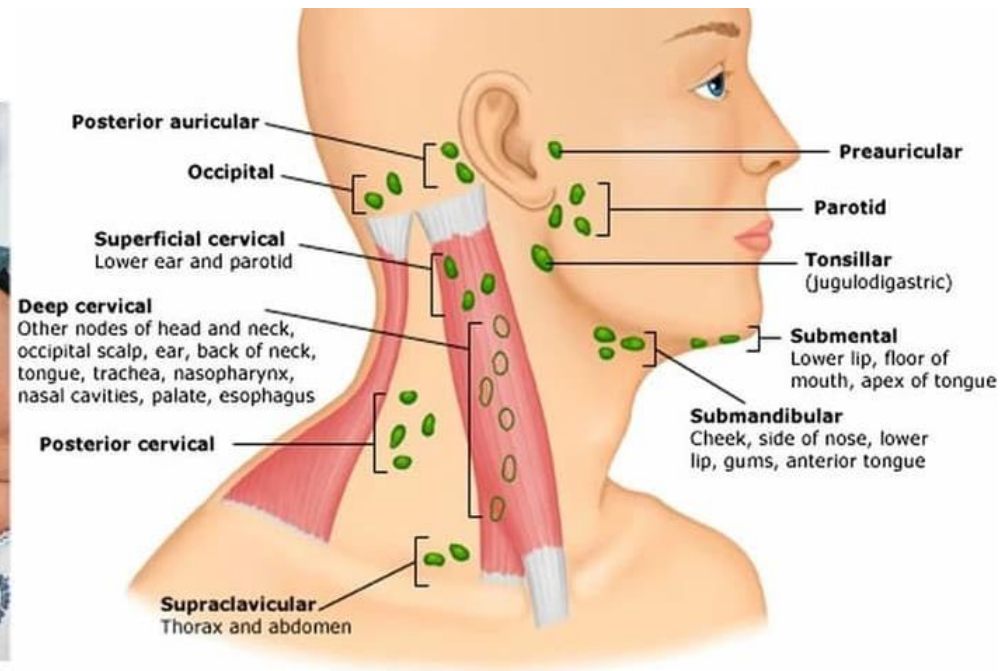
Kelainan pada laring



Pemeriksaan kelenjar leher



Copyright © 2015 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins



Poli THT-RSU Karsa Husada, Batu

